চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ

জাতীয় কর্মকৌশল





সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা- ১২১২

০২/ ১২/ ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ২
লক্ষ্য ২
উদ্দেশ্য ৩
পটভূমি ৩
সি- জে মডেল ৩
বৈশিষ্ট্যসমূহ 4
কার্যক্রম ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
ক্রমবিকাশ 4
চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেল সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা ১২
পর্যায় ভিত্তিক কমিটিসমূহ ১৪
কর্মকৌশল বাস্তবায়ন সূচী ২০
জাতীয় *20*
প্রাতিষ্ঠানিক *20*
উপসংহার ২১
সংযুক্তি ২২
টেবিল ১. চৌগাছা মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক 22
টেবিল ২. ঝিনাইদহ মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক 23
টেবিল ৩. চৌগাছার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রমরে অগ্রগতির মূল্যায়ন (১৯৯৫-২০১৭) 24
টেবিল ৪. ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কার্যক্রমের অগ্রগতির মূল্যায়ন (১৯৯৮- ২০১৭) 25
টেবিল ৫. খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রসুতি সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম ২০১১ ও ২০১৭ সালের তুলনামূলক চিত্র 25
টেবিল ৬. বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারী সম্পদ ব্যয়ের তুলনামূলক তথ্য 26
টেবিল ৭. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা৯ 27
মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা 29
ক। জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে *29*
খ। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে *33*

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপাদানসমূহ হল- সকলের জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্য সেবা, সবার জন্য একই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা স্বত্ত্বেও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সিজে -)জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যে একটি আদর্শ মডেল হিসাবে দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তাই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার সকল উপাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সি জে -জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেলকে সারাদেশে সকল জেলা উপজেলায় সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ মডেলের সাফল্যের একটি বড় উপাদান হল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে স্থানীয় জনগণের অধিকার বোধ এবং সেজন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে যে কোন অসুবিধা এবং অভিযোগ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়। আর একটি উপাদান হচ্ছেঃ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে স্থানীয় জনগণ ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী সরবরাহ করা। এছাড়াও, এ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তিবর্গের (চিকিৎসক, সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী) নিরাপত্তা বিধান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জনবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার এ মডেলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, স্থানীয় চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ, আইন শৃংখলা বাহিনী, সাংবাদিক, শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা, বিত্তশালী দাতা ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন।

যে সব স্থানে এ মডেল পূর্ণ বা আংশিকভাবে চলমান সেখানে স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়েছে, সর্বোপরি সুশাসন ও জনপ্রশাসনের জনকল্যাণধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। যে সব দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে সে সব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সরাসরি স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্ত থাকে। আমাদের দেশেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। সি- জে মডেল তার উদাহরণ। এ উদাহরণকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশের সকল জেলা উপজেলার সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে পর্যায়ক্রমে সি- জে মডেল সম্প্রসারণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য।

লক্ষ্য

বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ২০২২ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সি- জে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেলের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা

জুন ২০২০ সাল নাগাদ – ২৭ উপজেলা ও ১৮ জেলা;
জুন ২০২১ সাল নাগাদ – আরো ২৫০ উপজেলা ও ৩৫ জেলা;
জুন ২০২২ সাল নাগাদ – অবশিষ্ট সকল উপজেলা ও জেলা।

উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবর্জনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ
২. সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দকৃত সম্পদ ও সুযোগ- সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৩. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও বহুমুখী অবদানের সুযোগ সৃষ্টি
৪. নানাবিধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে দলগত কর্মকৌশলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ
৫. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন এর মাধ্যমে ধারাবাহিক সফলতা, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
৬. নেতৃত্বগুণের বিকাশ ও উদ্বুদ্ধকরণ
৭. বিষয়ভিত্তিক সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন

পটভূমি

জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবার নিজেদের ও সমাজের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার সামর্থ্য অর্জন করে। প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে জনগণ নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্হাপনায় অংশ গ্রহণ করে। জনগণ এক্ষেত্রে তিন ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে - (১) পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ (২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, জনবল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা; এবং (৩) জনসচেতনতা তৈরি করা ও স্বাস্থ্য সেবায় যুক্ত হয়ে তা ব্যবহারে সহায়তা করা।[১] বাংলাদেশে সফল'টিকাদান কর্মসুচি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন – সরকারী কার্যক্রমের সাথে জনসম্পৃক্ততার উজ্জ্বল উদাহরণ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফল মাইলফলক হল চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) মডেল। বর্তমান বছর সহ বিগত প্রায় ১৫ বছর ধরে উপজেলা শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা শ্রেণীতে গত ৬ বছর শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে ঝিনাদহ জেলা সদর হাসপাতাল স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পুরস্কার (২০১৬ ও ২০১৭) সহ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে এ মডেলের সার্থকতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

সি- জে মডেল

সি- জে মডেল হল উপজেলা- জেলা পর্যায়ের সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, যা নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জনকল্যাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ দক্ষ ব্যক্তি ও দলের নেতৃত্বে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং জনগণের সহযোগিতা নিয়ে স্বল্প সময়ে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করে আস্থাশীল সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় জনগণের অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত করে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. নেতৃত্ব
২. ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা
৩. জনসম্পৃক্ততা
৪. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়
৫. নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি
৬. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৭. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৮. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ
৯. জন্ম- মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি
১০. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা
১১. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধন
১২. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা
১৩. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন
১৪. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে "৫এস কাইজেন- টিকিউএম" বাস্তবায়ন
১৫. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে কার্যক্রম

১. নেতৃত্ব

চৌগাছা ঝিনাইদহ মডেল সৃষ্টিতে নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সততা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা বৈশিষ্টের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কখনো একক কখনোবা যৌথ নেতৃত্বও এ মডেলে ভূমিকা রেখেছে । ফলে এ সিজে মডেল সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

২. ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা

চৌগাছা- ঝিনাইদহ আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ডা. ইমদাদুল হক পথিকৃতের(রোল মডেল) ভূমিকা পালন করেছেন। তার সততা, আন্তরিকতা, কর্মনিষ্ঠা এই কর্যক্রমে মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। তবে যৌথভাবে একই মানসিকতার সহকর্মীদের সহযোগিতা ও সমন্বয় ছাড়া রোল মডেলের ভূমিকা

পালন করা সম্ভব ছিলনা। চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল মান্নান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুর রাজ্জাক ও মেডিকেল অফিসার ডা. সেলিনা খাতুন অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ঝিনাইদহ ও চৌগাছা উভয় স্থানেই স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সক্রিয় ভূমিকা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এ মডেল সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। তাদের উদ্যোগকে উৎসাহ যুগিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যসেবা দানকারীগণ। এছাড়াও রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অব্যাহত সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান। এ মডেলের সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ দলের মধ্য হতে কারো না কারো উদ্যোগী ভূমিকা। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগী ভূমিকা এ মডেল বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৩. জনসম্পৃক্ততা

মডেল শয্যা ব্যবহারের হার বেড়েছে, সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থা বাড়ার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সরকারী হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার পরিধি আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। একদিকে বহির্বিভাগে সুশৃঙ্খল বিষয়ভিত্তিক সেবার কারণে যেমন রোগীর সংখ্যা ও সন্তুষ্টি বেড়েছে, অন্যদিকে অন্তর্বিভাগে বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কারণে বড় অপারেশনের সংখ্যা বাড়ায় শয্যা ব্যবহারের হারও বেড়েছে অনেকগুণ।

৪. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে জনপ্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা সমাজকল্যাণসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহের ভিতরে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সি জে মডেল এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

৫. কমিউনিটি সাপোর্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি

হাসপাতালে সর্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে এ আদর্শ ব্যবস্থাপনাতে। নিরাপত্তা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানো এর কৌশলগত দিক। কমিউনিটি সহায়তা

গ্রুপ গঠনসহ জনসম্পৃক্ততার নীতির কারণে চিকিৎসক- রোগীর সম্পর্ক এক নতুন আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তুচ্ছ কারণে হাসাপাতাল, চিকিৎসক বা রোগীদের ওপর হামলা বন্ধ হয়েছে। পরস্পরের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

৬. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সকল গর্ভবতী মায়ের কমপক্ষে ৫ বার গর্ভকালীন সেবা সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের নিকট থেকে নিতে হবে এবং শত ভাগ মাকে হাসপাতালে ডেলিভারী করাতে হবে। এটি ছিল চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যতম মূল মন্ত্র। বারবার আসার ফলে প্রসূতি মায়েদের সাথে সেবা দানকরীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ও হাসপাতালের কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা ও আস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারিতে উৎসাহী ও সাহসী হয়ে ওঠে। সেখানে জরুরী ধাত্রী সেবা (ইওসি) অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে প্রদান করায় স্বাভাবিক প্রসবের হার বেড়েছে ও সিজারিয়ন সেকশনের হার কমেছে ফলে মাতৃমৃত্যুর হার ও নবজাতক মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উন্নত মাতৃসেবার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণকে রক্তদানে উৎসাহিত করে এবং জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ত সংগ্রহ ও রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যাবস্থা করেছেন। প্রসূতি মায়েদের জরুরী স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে হাসপাতালে সর্বক্ষণিক (২৪/ ৭) জরুরী অপারেশন সেবা চালু আছে। কাজ গুলিকে সহজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক (নার্স সহযোগী) ব্যবস্থা চালু করে জনবল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সন্তুষ্টির নামে টাকা নেওয়া বা মিষ্টি খাওয়া সম্পুর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রসূতি মায়েদের জন্য অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওয়ার্ডটিকে দুর্গন্ধমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে জুতামুক্ত পরিবেশ ও নারী বান্ধব করা হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিপদে অর্থ সঞ্চয়ের নিমিত্তে মাটির ব্যাংক প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

৭. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্থানীয় উদ্দোগে ১৯৯৬ সাল থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুর্দ্ধ ৫ বছরের শিশুদের জন্য আন্ডার ফাইভ কর্ণার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যা সরকারিভাবে আএমসিই কর্ণারের নামে চালু হয় ২০০৭ সালে । আন্ডার ফাইভ কর্নারে, শিশুদের পুষ্টিমান পরিমাপের জন্য গ্রোথ চার্ট ব্যবহার করা হয়। শিশুদের ইপিআই

টিকা, ডায়রিয়া ও নিমোনিয়ার চিকিৎসা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এখান থেকে সকল শিশুকে রেফার্ড করে একজন নিধারিত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির অন্তঃবিভাগে ১৯৯৬ সাল থেকে পৃথক শিশু ওয়ার্ড খোলা হয়। এ কার্যক্রম চৌগাছাতে ধারাবাহিক ভাবে চলার ফলে শিশু মৃত্যুহার ও অপুষ্টির হার কমেছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়ার কারণে নবজাতক মৃত্যু কমেছে। ফলে শিশু স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

৮. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করে বিষয়ের ভিত্তিতে সেবা দেয়া হয়েছে। এ মডেলের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে লিঙ্গ, বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকার ভেদে পুরুষ, মহিলা, কৈশোর স্বাস্থ্য, আইএমসিআই, এএনসি, পিএনসি, ভায়া, ইপিআই, ব্রেস্ট ফিডিং, ওআরটি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, এনসিডি ইত্যাদি বিষয়ে কর্নার তৈরী করে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে অন্তঃবিভাগকে চারটি ভাগে ভাগ করে পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং প্রসূতি বিভাগে পৃথক করায় বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্বশীলদের দায়বদ্ধতায় আনা গেছে, রোগীদের অপেক্ষার সময় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, সর্বোপরি রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবায় উন্নতি হয়েছে।

৯. জন্ম- মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যয়নের ক্ষেত্রে, জন্ম- মৃত্যু তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগ দুটিতে জন্ম তথ্য সঠিক ভাবে সংগ্রহ করা হলেও মৃত্যু তথ্য সংগ্রহে দুর্বলতা দেখা যায়। ফলে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নবজাতক মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃমৃত্যুহার সহ বয়স ও রোগ ভিত্তিক সঠিক মৃত্যু তথ্য জানা সম্ভব হয় না। ফলে কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন এমনকি দায়বদ্ধতা ও সৃষ্টি করা যায়নি। চৌগাছা উপজেলায় ১৯৯৫ সাল থেকে প্রাথমিক ভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে দীর্ঘ ২২ বছর চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে।

১০. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। রোগীদের আচরণ পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম (যেমনঃ প্রসূতি সেবা, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগ, পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, জলাতংক প্রভৃতি) এবং অন্যান্য সরকারী সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে জানানো এবং সরকারী সেবা নিতে উৎসাহিত করা এ স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য। দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে মাঝে মাঝে রোগীদের সমস্যা ও সুপারিশসমূহ অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তিনটি এবং চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্সে এ ধরণের দু'টি স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্নার চালু আছে। প্রতি দিনেই এ কার্যক্রম অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্নারে রোগীদের বসার স্থান এবং অন্যান্য সুবিধা রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক রোস্টারের মাধ্যমে এবং দায়িত্ব বন্টন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

১১. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধন

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা একদিকে হাসপাতালে রোগ সংক্রমণের আশংকা থেকে দূরে রাখে, অন্য দিকে দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশে রোগীদের সংবেদনশীল মন উৎফুল্ল রাখতে সহায়তা করে। পরিচ্ছন্নতা শুধু হাসপাতালেই নয়, বহিরাঙ্গনসহ গোটা এলাকাকেই পরিচ্ছন্ন রাখা অপরিহার্য। প্রাঙ্গনে আকর্ষণীয় ফুলের বাগান, ভেষজ বাগান তৈরী ও তা নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার জন্য সরকারী জনবলের বাইরে জনগণের আর্থিক সহায়তায় অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করাতে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। বর্জ্য ব্যাবস্থার উন্নয়নের ফলে হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত হয়েছে। চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন জাতীয় দিবসে একসাথে নিজেরাই গোটা হাসপাতাল ও প্রাঙ্গনে ঝাড়ু হাতে পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশ নেন। এটিকে "বিগ ক্লিনিং ডে" বলা হয়।

১২. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন স্বাস্থয সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যে কোন বড় অস্ত্রোপচার বিশেষ করে সিজার অপারেশনের সময় ও প্রসূতি মায়েদের প্রসবকালীন

নিরাপদ রক্তের জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৯৯৬ সালের বিজয় দিবসে রক্তদাতা সংগ্রহের লক্ষ্যে রক্ত গ্রুপিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। সে সকল ব্যক্তিদের রক্ত গ্রুপিং করে তালিকাবদ্ধ করা হয়, যাদের বাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে। প্রায় ৬০০ জন রক্ত দাতার নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়। এ সকল রক্ত দাতাকে "চলন্ত রক্ত ব্যাংক" হিসেবে অভিহিত করা হয়। তখন থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের জন্য কখনও রক্তের অভাব ঘটেনি। ফলে, জরুরি প্রসুতি সেবায় রক্তের অভাবে মাতৃমৃত্যু কমে যায়। রক্তদাতা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জাতীয় দিবসে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এমনকি দুর্গা পুজা মন্ডপেও এ উদ্যোগ নেওয়ায় সফলতা দেখা গেছে। রক্ত দাতাদের কাছ থেকে গভীর রাত্রে রক্ত সংগ্রহের জন্য আরেকটি দায়িত্বশীল গ্রুপ তৈরি করা হয়। ২০০৫ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের নিমিত্তে ব্লাড ব্যাংক চালু করা হয়।

১৩. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

হাসপাতালের সমস্যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। এ ধরণের সমস্যা মোকাবেলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদেরকে জনগণ সহায়তা প্রদান করছেন। কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের ভূমিকার কারণে প্রভাবশালীদের কারো কারো অবৈধ চাপ মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে। সেবাদানকারী নামধারী এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজদের মোকাবেলা করা, 'সন্তুষ্টি'র নামে রোগীদের কাছ থেকে অন্যায় উৎকোচ বন্ধ করাও সহজ হয়েছে; 'বেসরকারী আয়া/ ওয়ার্ড বয়' নামধারীদের জিম্মী দশা থেকে রোগীদেরকে তথা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেয়া নিয়ে নিয়মবহির্ভূত চাপ মোকাবেলা, রোগীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'দালাল' দের দৌরাত্ম্য মোকাবেলা সফলভাবে করছেন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

১৪. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে "৫,এস কাইজেন- টিকিউএম " (5,S Kaizen Total Quality Management) বাস্তবায়ন

হাসপাতালে মানসম্পন্ন সেবার ১ম ৫টি ধাপ হলো ৫S।

১ম Sort -অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কর্মস্থল থেকে সরিয়ে ফেলা,

২য় Set - প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখা,

৩য় Shine - পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা,
৪র্থ Standardize- উপরের তিনটি কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা,
৫ম Sustain- উল্লেখিত কার্যক্রম সমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
Kaizen - জাপানি শব্দ কাইজেন এর অর্থ Change for better বা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি।
সার্বিকভাবে ৫S কাইজেন পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসম্পন্ন সেবাদান সম্ভব।

১৫. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

এ আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবাসমূহ যান্ত্রিকভাবে খন্ড খন্ড বিবেচনা না করে রোগীর প্রয়োজন বিবেচনা করে তার সামগ্রিক সেবা নিশ্চিত করা। এ ব্যবস্থাপনায় সেবাদানকারী তার নিজের পেশাগত খন্ড কাজ সম্পন্ন করেই তার দায়িত্ব শেষ এটা মনে করেন না। তিনি পরবর্তী ধাপে রোগী প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন কি না তা অনুসরণ করেন। কোন ওয়ার্ডের প্রধান তার রোগীদের ভর্তি হওয়া থেকে হাসপাতাল ছাড়া পর্যন্ত সেবা ব্যবস্থাপনার সকল দিককে বিবেচনায় রাখেন। তার ইউনিটের কর্মকর্তা- কর্মচারী সময়মত উপস্থিতি, ইউনিটের পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা, রোগীদের খাদ্য সরবরাহ, ওয়ার্ডের অনাবশ্যক ভীড় নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিষয়কে বিবেচনায় আনেন। ঝিনাইদহ হাসপাতালে এ বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাদানকারীকে একই সাথে স্তরভেদে তার বিশেষায়িত কাজের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার দিকটিকেও সৃজনশীল ও মানবিকভাবে দেখা হয়েছে।

ক্রমবিকাশ

চৌগাছা- ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল এর প্রাথমিক সূচনা ১৯৮৫ সালে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায়। তৎকালীন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা ডা. হুমায়ুন মোল্লা[২] এর নেতৃত্বে একদল তরুণ চিকিৎসকের হাত ধরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি বহিঃবিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার ব্যপ্তি ঘটে, তরুণদের অন্যতম একজন ছিলেন ডা: মো: ইমদাদুল হক। সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রয়োগ করে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জকে সফলভাবে মোকাবেলা করেন। ১৯৮৬ সালে উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় একটি

টালির ঘরে থাকা অপরিসর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি নিকটস্থ পাবলিক লাইব্রেরিতে সম্প্রসারিত হয়, খোলা হয় অন্তঃবিভাগ, তৈরি হয় ইপিআই ভবন। স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় ক্লাব- সমিতি ও জনগণের সহযোগিতায় চক্ষু ক্যাম্পসহ নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ফলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইপিআই কাজের সফলতায় জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার তথা স্থানীয় জনগণকে সফলভাবে সম্পৃক্ত করেন এ চিকিৎসক দলটি। স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতা ছিল এ নতুন ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনগণের আস্থা অর্জনে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ডা: হকের নেতৃতে নড়াইল জেলার লোহাগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চৌগাছার জনসম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত আরো বিস্তৃত হয় ১৯৮৯- ৯৫ সালে । তিনি উদ্যোগী হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসক, শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং লোহাগড়ায় জন্মগ্রহণকারী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেন।[৩]

চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৬- শয্যা থেকে ৩১- শয্যায় উন্নীত হয়ে ১৯৯৪ সালে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আব্দুল মান্নান। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে তিনি নতুন ভবনে ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রসূতি ওয়ার্ড চালু করেন। ১৯৯৫ সালে ডাঃ ইমদাদুল হক পুনরায় চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি হয়ে আসেন। তার সাথে ছিল লোহগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। ঐ সময়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা, ওআরটি কর্ণার, ইপিআই কর্ণার, ও জন্ম মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালু হয় – যা ছিল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সচরাচর কার্যক্রমের বাইরে। ১৯৯৫- ১৯৯৮ সালে জাইকার (জাপান) ফ্রন্টলাইন এমসিএইচ প্রোগ্রামের অধীনে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ এএসএম আব্দুর রাজ্জাক ও ডাঃ সেলিনা খাতুন চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করেন। তাদের সহযোগিতায় মাতৃ- শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে গিয়ে স্থানীয় উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গর্ভবতী মায়েদের জন্য গর্ভকালীন সেবার উদ্দেশ্যে এন্টেনেটাল কর্ণার ও অনুর্ধ ৫ বছরের শিশুদের জন্য আন্ডার ফাইভ কর্ণার, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে বেজ লাইন জরিপ করে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এ সময়ে জনপ্রশাসন, দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগীতায় সেনিটেশন উন্নয়ন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ কার্যক্রম চালু করা হয়।[৪] প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ৮টি উপাদানের সফল বাস্তবায়নে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল সবার শীর্ষে। জনবান্ধব সৃজনশীলতা ও জনসম্পৃক্ততা ছিল এ সাফল্যের চাবিকাঠি। ১৯৯৮ সালে চৌগাছার ৮ জন নার্সকে যশোরের আদ- দ্বীন হাসপাতাল থেকে প্রসূতি সেবার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সে সময় প্রসূতি সেবাতে নার্সদের এখনকার মত দক্ষতা ছিল না। ২০০০ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় জরুরি প্রসুতি সেবা কার্যক্রমের অধীনে 'কম্প্রেহেন্সিভ ইওসি' কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মডেলটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়।

স্থানীয়ভাবে ২০০১ সালে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি ভিশন- ২০১০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়, যা ছিল উপজেলা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রম। কমিউনিটি সহযোগীতায় জনবল সংগ্রহ করে ২০০৬ সালে নতুন প্রসূতি ভবন চালু করা হয়।

চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ২০০৮ সালে ৩১-শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত হয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মডেল হিসেবে ঘোষণা করে। এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডা. মার্গারেট চ্যান চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং মডেলটিকে সারা দেশে সম্প্রসারণের বিষয়ে সুপারিশ করেন।[৫]

উপজেলাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ১লা জানুয়ারি ২০১১ সালে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু হয়, যার মূলে ছিল স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সৃজনশীল উদ্যোগ।[৬] মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপের কারণে ২০১১ সালে ডিসেম্বর মাসে চৌগাছার প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির হার ৯০% এর বেশি হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে উদাহরণ সৃষ্টি করার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালের মে মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করার কার্যক্রম শুরু করে।

ডাঃ মো. ইমদাদুল হক ২০১২ সালের মে মাসে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি) হিসেবে যোগদান করেন। হাসপাতালটি তখন জনবলের অপ্রতুলতা, নিরাপত্তাহীনতা ও অব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছিল। তাঁর উদ্যোগে চৌগাছা মডেলের আলোকে সার্বিকভাবে হাসপাতালটির পরিবেশের ও চিকিৎসা মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে। ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ঝিনাইদহ হাসপাতালকে জেলা পর্যায়ের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৫ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) মডেলের আলোকে ১০টি জেলা হাসপাতালে এ কার্যক্রম সম্প্রসারন করে এবং বর্তমানে মোট ১১টি জেলা হাসপাতাল ও ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) মডেল সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা

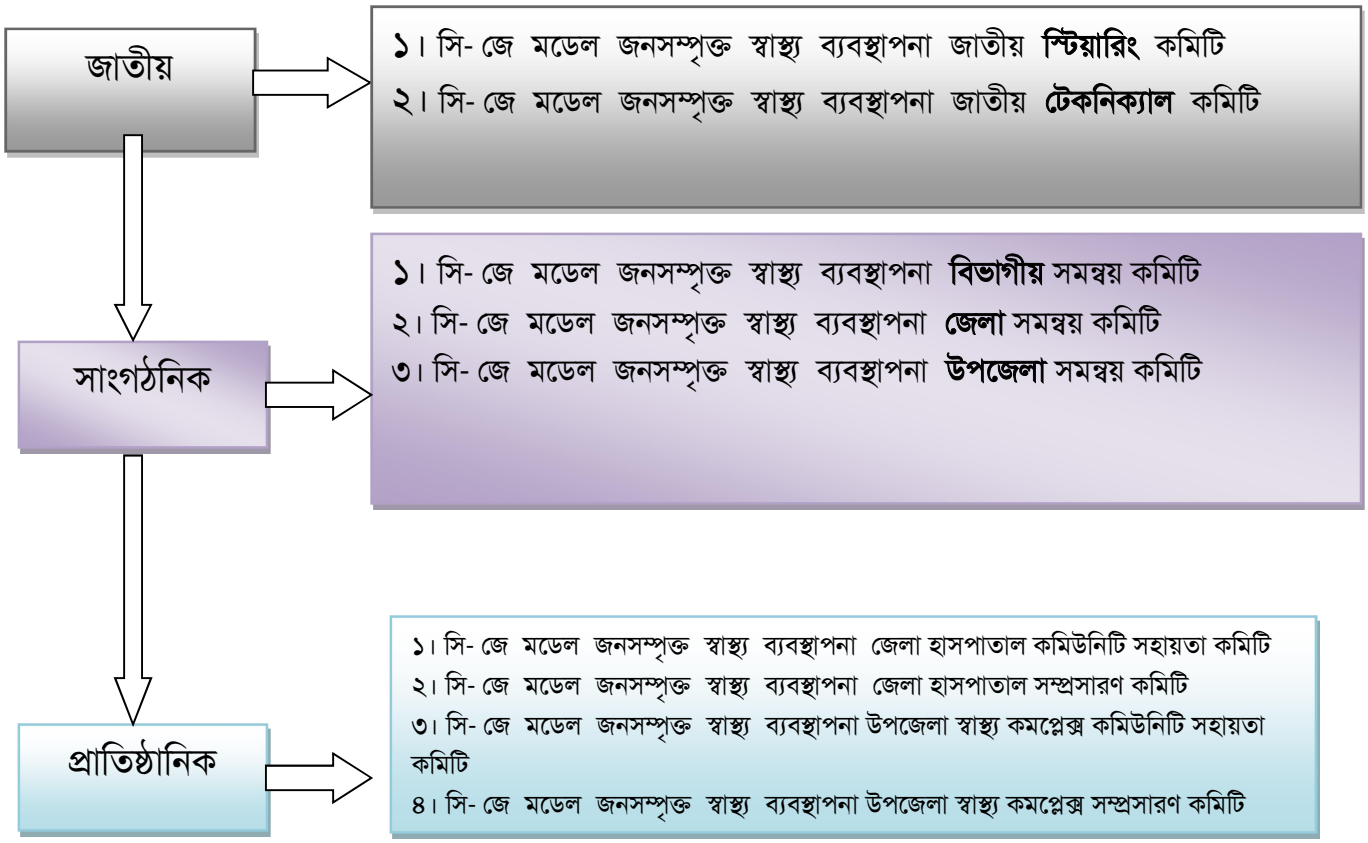
বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতার পর ২০৩২ সাল নাগাদ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। এ বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, রয়েছে নানারকম সীমাবদ্ধতা।[৭] এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাই সরকারের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্বলিত চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) মডেল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য সেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিগত ২২ বছর যাবৎ যশোরের চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং গত ৬ বছর যাবৎ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল সহ আরও প্রায় ১৫ টি স্থানে সফলতার সাথে এ মডেলের কার্যক্রম চলছে।

যে সব স্থানে এ মডেল চালু হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন সেখানে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ করা সম্ভব হয়েছে, স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব

হয়েছে, সর্বোপরি সুশাসন ও জনকল্যাণধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মাতৃ- শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ বাংলাদেশে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' তথা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করতে হলে, দেশব্যাপী উপজেলা- জেলা পর্যায়ে চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল- এর সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন হবে প্রমাণ নির্ভর, সময়োপযোগী এবং যুক্তিযুক্ত উদ্যোগ।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সুপারিশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আলোকে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে মডেলের সফল বাস্তবায়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সি- জে মডেল সারাদেশে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পর্যায় ভিত্তিক কমিটিসমূহ



প্রশাসনিক পর্যায়ে	সাংগঠনিক পর্যায়ে	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে
মন্ত্রণালয় পর্যায়ে (জাতীয়)	ক) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (জাতীয়)	খ) জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	
বিভাগীয় পর্যায়ে	বিভাগীয় সি- জে মডেল সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি	
জেলা পর্যায়ের কমিটি	জেলা সি- জে মডেল সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি	ক) জেলা হাসপাতাল কমিউনিটি সহায়তা কমিটি খ) জেলা হাসপাতাল সি- জে মডেল সম্প্রসারণ কমিটি গ) ওয়ার্ড কার্যক্রম উন্নয়ন কমিটি
উপজেলা পর্যায়ে	উপজেলা সি- জে মডেল সম্প্রসারণ কমিটি	ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি সহায়তা কমিটি খ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সি- জে মডেল সম্প্রসারণ কমিটি গ) ওয়ার্ড কার্যক্রম উন্নয়ন কমিটি

প্রতিবেদন প্রেরণ ও কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন:

বিভিন্ন কমিটির কাছে আসা তথ্যগুলি, জাতীয় সি- জে মডেল সম্প্রসারণ কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

১) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি একসাথে বছরে ২ বার অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।

২) জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি ২ মাস অন্তর বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন।

৩) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলি প্রতিমাসে তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন। কমিটিগুলি তাদের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২ ভাবে প্রেরণ করবেন।

ক. সরাসরি সি- জে মডেল জাতীয় সম্প্রসারণকমিটির নিকট

খ. উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ হয়ে অধিদপ্তরের MIS এ প্রেরণ করবেন।

৪) একটি নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসে সিভিল সার্জন জেলার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি সভার প্রতিবেদন বিভাগীয় পরিচালক ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির কাছে প্রেরণ করবেন

৫) অনুরূপভাবে তত্ত্বাবধায়ক জেলা হাসপাতাল কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি সভার প্রতিবেদন একটি নির্ধারিত ছকে সিভিল সার্জন, বিভাগীয় পরিচালক ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির কাছে প্রেরণ করবেন

৬) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি সভার প্রতিবেদন একটি নির্ধারিত ছকে সিভিল সার্জনের নিকট প্রেরণ করবেন।

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	চেয়ারপারসন
২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব
৩.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মুল্যায়ন), সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি, ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	---------	
১১.	------	
১২.	----------	
১৩.	----------	
১৪.	----------	
১৫.	----------	
১৬.	-------	
১৭.	----------	
১৮.	----------	

কার্যপরিধিঃ

১. নীতিমালা, কর্মকৌশল অনুমোদন
২. সি- জে মডেল জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশমালা গ্রহণ
৩. অর্থ বরাদ্দ ও অনুমোদন
৪. বছরে ন্যূনতম দু'বার বৈঠকে বসবে
৫. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জাতীয় **টেকনিক্যাল** কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	উপদেষ্টা
২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	চেয়ারপারসন
৩.	প্রধান সমন্বয়কারী, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব
৪.	পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	লাইন ডাইরেক্টর,কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	ফোকাল পারসন, কিউআইএস সেক্রেটারিয়েট, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী, হেলথ সিস্টেমস এন্ড পপুলেশন স্টাডিজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর, বি	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, ইউনিসেফ, ঢাকা	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, জাইকা, ঢাকা	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসাসিয়েশন (বিএমএ)	সদস্য
১৬.	ডা. মুশতাক হোসেন, সমন্বয়কারী, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	ডা. ইমদাদুল হক, সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী), ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল [পিআরএল]	সদস্য ও কনসালট্যান্ট
১৮.	মেডিক্যাল অফিসার (৩ জন), সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য

কার্যপরিধি

১. দেশের অন্যান্য জেলা- উপজেলাতে "চৌগাছা- ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল" সম্প্রসারণ
২. একদসংক্রান্ত নির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা, এসওপি, ফরম, অ্যাপস, পরিবীক্ষণ ফরম প্রস্তুত করা
৩. এ যাবত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ সংক্রান্ত সকল কাজের পর্যালোচনা ও সার- সংকলন
৪. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা
৫. প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা
৬. জেলা- উপজেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন
৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশে এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা
৮. কমিটি কমপক্ষে মাসে একবার বা প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে
৯. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা **বিভাগীয়** সমন্বয় কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য)	চেয়ারপারসন
২.	সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য)	সদস্য সচিব
৩.	সকল সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	সকল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক	সদস্য
৫.	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বিভাগীয় সমন্বয়কারী, কিউআইসি	সদস্য

৭.	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

১. বিভাগের অন্তর্গত জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী হাসপাতালে কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ কমিটিসমূহের কার্যক্রম প্রতি মাসে মূল্যায়ন করবেন

২. জেলা পর্যায়ের প্রতিবেদন ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির কাছে প্রেরণ করবে

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা **জেলা** সমন্বয় কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ	চেয়ারপারসন
২.	সিভিল সার্জন	সদস্য সচিব
৩.	সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার, সদর হাসপাতাল	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ)	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

১. জেলার অন্তর্গত সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কমিউনিটি সহায়তা কমিটিসমূহের কার্যক্রমে সহায়তা ও মূল্যায়ন করবেন

২. জেলা পর্যায়ের প্রতিবেদন ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জাতীয়ও বিভাগীয়সম্প্রসারণ কমিটির কাছে প্রেরণ করবেন

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা হাসপাতাল কমিউনিটি সহায়তা কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	পৌরসভা মেয়র	চেয়ারপারসন
২.	সিভিল সার্জন	সমন্বয়ক
৩.	তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সদর হাসপাতাল	সদস্য সচিব
৪.	সংশ্লিষ্ট আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৫.	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৬.	ডেপুটি কমিশনারের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৭.	পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৯.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য ও ফোকাল পারসন
১০.	কনাসলটেন্ট (১ জন)	সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এর প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১২.	আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১৩.	প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১৪.	এনজিও'র প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

১. চৌগাছা- ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার আলোকে অত্র হাসপাতাল পরিচালনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ

২. হাসপাতালের মানসম্মত সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ করে চিকিৎসার পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
৩. সরকারী বরাদ্দ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
৪. চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি স্থানীয় দাতা ও হিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট করা, তাদের সহায়তায় একটি কমিউনিটি সাপোর্ট তহবিল গঠন এবং এ বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা
৫. চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয়ভাবে তা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ
৬. হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সেবা প্রদান কাজে উৎসাহ প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান
৭. সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাবে
৮. কমিটি কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজনে উপ- কমিটি গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা হাসপাতাল সম্প্রসারণ কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	তত্ত্বাবধায়ক, জেলা হাসপাতাল	চেয়ারপারসন
২.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য সচিব
৩.	বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র ফ্যাসিলিটর ও টিম লিডারগণ	সদস্য

কর্মপরিধি

১. বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা
২. পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা
৩. নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসের প্রথম মাসে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রেরণ
৪. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সহযোগিতা প্রয়োজন তা নির্ধারণ কওে প্রস্তাবনা আকারে কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপে সুপারিশ করা
৫. বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র উপস্থাপিত সমস্যাসমূহের সামধান পদ্ধতিকে অনুমোদন দেয়া

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি সহায়তা কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারপারসন/ সভাপতি
২.	মেয়র, পৌরসভা	সহ সভাপতি
৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা - সদস্য সচিব	সদস্য সচিব
৪.	সংশ্লিষ্ট আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৫.	উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৬.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৭.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৮.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৯.	উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা (১ জন)	সদস্য
১০.	প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১১.	এনজিও'র প্রতিনিধি (ইউএনও মনোনীত) (১ জন)	সদস্য
১২.	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (ইউএনও মনোনীত) (১ জন)	সদস্য
১৩.	কনসালটেন্ট (১ জন)	সদস্য
১৪.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (১ জন)	সদস্য

সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ কমিটি

১. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা - চেয়ারপারসন
২. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার - সদস্য-সচিব ও ফোকাল পারসন
৩. ডাব্লুআইটি কমিটিসমূহের টিম লিডার ও ফ্যাসিলিটেটর

কর্মপরিধি

১. প্রতি মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান করবে
২. কমিউনিটি হতে কোন ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করবে
৩. প্রতিটি ডাব্লু আইটি কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে
৪. উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন

ওয়ার্ড কার্যক্রম উন্নয়ন কমিটি (WIT)

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক - ফ্যাসিলিটেটর
২. ওয়ার্ড/সেকশন ইন চার্জ নার্স - টিম লিডার
৩. সিনিয়র স্টাফ নার্স - সদস্য সচিব
৪. আয়া/ওয়ার্ড বয় (১ জন) - সদস্য
৫. ক্লিনার (১ জন) - সদস্য

কর্মপরিধি

১. প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে আধা ঘন্টার জন্য সভায় মিলিত হবে
২. সমস্যা চিহ্নিত করবে ও স্থানীয়ভাবে সমাধানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি অনুসরণ করবে
৩. সাপ্তাহিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে কিউআইসি'র ফোকাল পারসনকে প্রেরণ করবেন

কর্মকৌশল বাস্তবায়ন সূচী

জাতীয়

নং	কর্ম	বাস্তবায়নকারী	সময়কাল	মন্তব্য
১.	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি গঠন	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সম্পন্ন
২.	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ডিসেম্বর '১৮	-
৩.	হাতে- কলমে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	ডিসেম্বর '১৮	-
৪.	দেশব্যাপী প্রাথমিক জরীপ	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র	-	সম্পন্ন
৫.	সি- জে মডেল বাস্তবায়িত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	-	সম্পন্ন
৬.	কর্মকৌশল প্রস্তুত করা	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র	-	চলমান
৭.	কর্মকৌশল চূড়ান্তকরণ	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	ডিসেম্বর '১৮	-
৮.	প্রথম পর্যায় জেলা- উপজেলা চিহ্নিতকরণ	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	-	সম্পন্ন
৯.	প্রথম পর্যায়ের জেলা- উপজেলার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	ডিসেম্বর'১৮- জানুয়ারি'১৯	-
১০.	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	ডিসেম্বর'১৮- জানুয়ারি'১৯	-
১১.	সকল পক্ষের অংশগ্রহণে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	জানুয়ারী'১৯	-
১২.	প্রথম পর্যায়ের জেলা- উপজেলাতে বাস্তবায়ন শুরু	স্বাস্থ্য অধিপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	ফেব্রুয়ারি'১৯	-
১৩.	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন/ তত্ত্বাবধায়ক জেলা হাসপাতাল	জানুয়ারি'১৯	-
১৪.	দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	মার্চ ২০১৯	-
১৫.	সি- জে মডেলের টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখা	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি ও কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ	-	চলমান

প্রাতিষ্ঠানিক

নং	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা
১.	কমিউনিটি সহায়তা কমিটি গঠন	স্থানীয় হাসপাতাল/ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	১৫ দিন
২.	প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	৩০ দিন
৩.	সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	৩০ দিন
৪.	দূরদৃষ্টি, লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	কিউআইসি দল	১৫ দিন
৫.	লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠী ও সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জনে কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ	স্থানীয় হাসপাতাল/ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	৯০ দিন

৬.	প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহ	স্থানীয় হাসপাতাল/ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	১৮০ দিন
৭.	মূল্যবোধভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার নীতিমালা প্রস্তুত করা	কিউআইসি দল	১৫ দিন
৮.	লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীদারের সাথে মতবিনিময়	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৬০ দিন
৯.	মানসম্পন্ন সেবাদানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৭ দিন
১০.	প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	----------
১১.	মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের জন্য সফর	জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি	৭ দিন
১২.	কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	প্রতি ৯০ দিন অন্তর

উপসংহার

স্বাস্থ্য সেবা একটি বহুমাত্রিক মানবিক ব্যবস্থা। মানুষের রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুনর্বাসন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এটি কোন অবস্থাতেই সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই জনসম্পৃক্ততা অপরিহার্য। চৌগাছা- ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই ব্যাবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সেবাদানকারীদের নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন- দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সেবার মান বেড়েছে। বেড়েছে রোগী সন্তুষ্টির হার। এ ব্যবস্থায় জনগণ স্বাস্থ্যসেবা, পরিকল্পনা ও বাস্তায়নে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। জনসম্পৃক্ততার ফলে ভবিষ্যতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সমস্যাসমমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানে ভূমিকা রাখা সহজ হবে। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষিত "সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা" কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ মডেল অনেকখানি ভূমিকা রাখবে।

সংযুক্তি

টেবিল ১. চৌগাছা মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক

১৯৮৬	স্থানীয় উদ্যেগে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ৬ শয্যার অন্তঃবিভাগ চালু।
১৯৮৯	ইপিআই কর্যক্রমে সফলতার জন্য জাতীয় পুরষ্কার লাভ
১৯৯৪	৩১ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানান্তর ও সেখানে ৬ শয্যার প্রসুতি বিভাগ চালু।
১৯৯৫	ওআরটি কর্ণার চালু, এবং জাইকার সহযোগিতায় ফ্রন্টলাইন এমসিএইচ কার্যক্রম শুরু
১৯৯৬	এএনসি কর্ণার, ও আন্ডার ফাইভ কর্ণার চালু
১৯৯৮	জানুয়ারি মাসে বেসলাইন সার্ভে পরিচালনা করা ও বার্ষিক রিপোর্ট- ১৯৯৭ তৈরি করা
২০০০	ইউনিসেফের সহযোগিতায় কম্প্রিহেনসিভ জরুরি প্রসুতি সেবা কর্যকম চালুকরা
২০০১	২০১০ সাল নাগাদ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন
২০০৪	প্রসুতি সেবায় জাতীয় পুরস্কার লাভ
২০০৬	ইউনিসেফের সহযোগিতায় নিরাপদ রক্ত- পরিঞ্চালন ইউনিট চালু
২০০৭	দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কার্যক্রম চালু
২০০৮	নারী বান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ
২০০৮ জুন	স্বাস্থ ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় কতৃক মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ও ৫০ শয্যায় উন্নীত
২০০৯	এমডিজি ৫ ও ৬ অর্জন
২০১০	বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থার মহাপরিচালক মারগারেট চ্যান এর চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও সারা দেশে সম্প্রসারণের সুপারিশ
২০১১ ১লা জানুয়ারি	২০১০ সালের লক্ষ্য মাত্রার সফল অর্জন ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু
২০১১ জুলাই	সার্বিক মান উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু
২০০৪- ২০১৪	প্রসুতি সেবায় সেরা জাতীয় পুরষ্কার লাভ
২০১৭	স্বাস্থ মন্ত্রী পুরস্কার লাভ ও প্রসুতি সেবায় পুরষ্কার লাভ

তথ্য সূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চৌগাছা যশোর

টেবিল ২. ঝিনাইদহ মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক

২০১২	মডেলের কর্যক্রম শুরু
২০১৩	কাইজেন রোল মডেল অ্যাওয়ার্ড পুরষ্কারলাভ
২০১৪	ঝিনাইদহ টিমের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন মান সম্পন্ন জেলা হাসপাতাল ২য় পুরষ্কার লাভ
২০১৫	মন্ত্রনালয় কর্তৃক জেলা পর্যায়ের মডেলের পাইলটিং শুরু ও শ্রেষ্ঠ মান সম্পন্ন জেলা হাসপাতাল পুরষ্কার লাভ
২০১৬	১০ টি জেলা হাসপাতালে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রীপুরষ্কার ও প্রসুতি সেবায় পুরষ্কার লাভ
২০১৭	স্বাস্থ্য মন্ত্রীপুরষ্কার ও প্রসুতি সেবায় পুরষ্কার লাভ

তথ্য সূত্র: তত্বাবধায়কের কার্যালয়, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

টেবিল ৩. চৌগাছার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রমরে অগ্রগতির মূল্যায়ন (১৯৯৫- ২০১৭)

বষিয়	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	২০০০	২০০৩	২০০৭	২০১১	২০১৭
শয্যা ব্যবহারের হার %	-	-	৭৮. ৯	৯৩. ৫	৮৮. ৯	২০১	২০৮	১৭১
এএনসি গ্রহীতার হার % (১ম বার)	-	১৬. ৩ (৮১৭)	২৪. ৬ (১২২৮)	৫৯ (২৮৬১)	৮৮ (৪৪৮৪)	১৩২ (৭২৯২)	১৭০ (৮৯৩৫)	১৩০ (৬৬৩২)
হাসপাতাল ডেলিভারী হার %	-	২. ১ (৯৯)	৩. ৪ (১৫১)	৬. ৪ (৪২২)	১৫ (৬৬১)	৩৮. ১ (১৮৯৯)	৯৮. ৪ (৪৪১৩)	৬৬ (২৯৩২)
সিজারিয়ান সেকসন হার %	-	. ০২ (১)	০	০. ০৭ (৩)	০. ৮ (৩৬)	৯. ৬ (৪৭৩)	২২. ৫ (১১০৭)	১৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার %	১. ৮৭	১. ৮৬	১. ৬৬	১. ৭	১. ৫৭	-	১. ৩৬	১.৭১
মাতৃ মৃত্যু হার /প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে	৫৯৯	৩০০	২০৬	১৬৮	১১৪	১৬০	৬৮	৯১
নবজাতক মৃত্যুর হার/প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৪২	৪৭	৪২. ৪	২৩	২৮	২১. ৫	১৮. ২	১৬.৬
শিশু মৃত্যুর হার(০-১)/প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৬৫	৫৮	৫৬	৩৬	৩৪	২৯. ২	২৩. ৬	১৮.৬
অনুর্দ্ধ পাচ বছরের শিশু মৃত্যুর হার/প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৭৮	৬৭	৬২	৪৪	৪৩	৩৩. ৩	২৫. ৭	২১.১
কম ওজনে শিশু জন্মের হার (%)	-	-	৩৬. ৫ (৭৪)	১৫. ২ (২৮৮)	১৩. ৭ (৬৩৬)	-	-	-

তথ্যসূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা, চৌগাছা, যশোর

টেবিল ৪. ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কার্যক্রমের অগ্রগতির মূল্যায়ন (১৯৯৮- ২০১৭)

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৯৮	২০১১	২০১২	২০১৫	২০১৭
১	বহিঃবিভাগ ও ইমার্জেন্সি রোগীর সংখ্যা	৮১৭৯৫	১৭০৮৫৪	১৭১০৭০	২৭৭৩০১	৩৪০৯৩২
২	অন্ত: বিভাগে ভর্তি রোগীর সংখ্যা	১২৯৭৩	২২৪৩৫	২২৯৫১	২৯৫৬২	৩৫৫৬৯
৩	শয্যা দখল হার %	১২৬	১৪৬	১৪৩	১৯৩	২৪২
৪	গর্ভবতি পরিচর্যার সংখ্যা	২৫৬	১৩৫৪	২২৬৮	১৩২৫১	১৫৩৬০
৫	মোট ডেলিভারির সংখ্যা	১১০৬	২৩৭৫	২৩৭৯	৩০৩৪	২৯৯৭
৬	মেজর অপারেশন সংখ্যা	-	৭৮০	৯৭৭	১৫৮২	১৫৭৮
৭	রাজস্ব আয় (টাকা)	-	-	-	৬০, ৪৪, ৭১৫	৭০, ৫৯, ৫৬০

তথ্যসূত্র: তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

টেবিল ৫. খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রসুতি সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম ২০১১ ও ২০১৭ সালের তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	প্রসুতি সেবার ধরন					
		স্বাভাবিক		সিজার অপারেশন		মোট	
		২০১১	২০১৭	২০১১	২০১৭	২০১১	২০১৭
১	চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৪০৬	২১৬৩	১০০৭	৭৫৯	৪৪১৩ (প্রথম)	২৯২২ (তৃতীয়)
২	খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৬৫৭	১৪৪৮	১৩৫৬	১৩৬৫	৩০১৩ (দ্বিতীয়)	২৫২৪
৩	২৫০ শয্যার যশোর জেনারেল হাসপাতাল	১৩৫৪	১১৭২	১৪৯৮	১৭৭৮	২৮৫২ (তৃতীয়)	২৯৫০ (দ্বিতীয়)
৪	২৫০ শয্যার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল	১৭৬২	১৫৯৫	৯১৫	৯১৯	২৬৭৭	২৫১৪
৫	১০০ শয্যার ঝিনইদহ সদর হাসপাতাল	১৯৪৭	১৮৫৪	৪৩০	১১৪৩	২৩৩৭	২৯৯৭ (প্রথম)

তথ্যসূত্র: এম. আই এস. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

টেবিল ৬. বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারী সম্পদ ব্যয়ের তুলনামূলক তথ্য

ক্রমিক নং	দেশ	মাথাপিছু বাৎসরিক সরকারি ব্যয় ($)	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় চিকিৎসকের সংখ্যা	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় সেবিকার সংখ্যা	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা	পকেট থেকে খরচ %
০১	যুক্তরাষ্ট্র	৯৫৩৬	২৫. ৫	৯৯	৩৭	১১. ০৮
০২	যুক্তরাজ্য	৪৩৫৬	২৮	৮৪	৩০	১৪. ৭৯
০৩	মালোয়েশিয়া	৩৮৬	১২. ৮	৩৪	১৮	৩৬. ৬৭
০৪	শ্রিলংঙ্কা	১১৮	৭. ৩	১৭. ৫	৩১	৩৮. ৪৩
০৫	ভারত	৬৩	৭. ৩	২০. ৪	০৯	৬৫. ০৬
০৬	নেপাল	৪৪	৮	৪. ৭	-	৬০. ৪১
০৭	পাকিস্তান	৩৮	৮	৬	০৬	৬৬. ৪৯
০৮	বাংলাদেশ	৩৭	৩. ৯	২. ২	০৩	৬৭

তথ্য সূত্র: www.worldbank.org Accessed on 20/10/2018

টেবিল ৭. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা৯

ক্রমিক নং	**সূচক** ***(প্রভাব/ফলাফল)***	**সূচনা বছরের তথ্য (সূচনা বর্ষ)**	**৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ নাগাদ**	**এসডিজি ২০৩০ সাল নাগাদ**
১	প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছরে)	৭০.৪ (এস ভি আর এস ২০১৩)	৭২	
২	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৩৭	২৫
৩	শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৩৮ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২০	
৪	শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)	১৭০ (এমএমইআইজি ২০১৩)	১০৫	৭০
৫	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের শিশুদের অনুপাত (%)	৩২.৬ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২০	
৬	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম উচ্চতার শিশুদের অনুপাত (%)	৩৬.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২৫	
৭	মোট উর্বরতা হার (প্রতি নারীর মাথা পিছু শিশু)	২.৩ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২.০	
৮	জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার (%)	৬২.৪ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৭৫	
৯	এক বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের সবগুলো টিকা নেয়ার হার (%)	৭৮ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৯৫	
১০	চিকিৎসক প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রসবকৃত শিশু জন্মের অনুপাত (%)	৪২.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৬৫	

১১	সম্পদের পঞ্চস্তর অনুযায়ী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জন্ম নেয়ার হার (উচ্চতম ও নিম্নতম পঞ্চমাংশের অনুপাত)	১৫:৬৯.৫ (বিডিএইচএস ২০১৪)	১:৩.৫	
১২	যক্ষ্মা সনাক্তের হার (%)	৫৩ (জিটিআর ২০১৪)	৭৫	
১৩	নবজাতকের মৃত্যু হার	২৫ (২০১৪)	১৮	১২
১৪	পাঁচ বছরের সম বয়সী শিশুদের কৃশতার হার	১৪	১২	
১৫	প্রসব পূর্ব স্বাস্থ্যসেবা (এএনসি) ৪র্থ সাক্ষাৎ	৩১.২	৫০	
১৬	শিশুকে কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো	৫৫.৩ (২০১৪)		
১৭	কিশোরীদের উর্বরতার হার (১৫-১৯)	৩১	২৫	

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা

ক। জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে

১)	জেলার নাম:		
২)	ক. তত্ত্বাবধায়কের নাম:		
	খ. মোবাইল নং:		
	গ. ই- মেইল:		
৩)	জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা		
৪)	জেলার তথ্য		
	ক. জেলার মোট জনসংখ্যা		
	খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা		
	গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা		
	ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা		
৫)	মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান		
	ক. সর্বনিম্ন:		
	খ. সর্বোচ্চ:		
৬)	বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ মাসওয়ারী		
	ক. সর্বোচ্চ		
	খ. সর্বনিম্ন		
৭)	মানবসম্পদ	পদ সংখ্যা	শুন্যপদ
	১. ক. চিকিৎসকঃ		
	১. খ. মেডিকেল অফিসার		
	১. গ. কনসালটেন্ট		
	২. নার্সঃ		
	৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী		
	৪. ওয়ার্ড বয়/ আয়াঃ		
৮)	মোট রোগীর সংখ্যা		
	ক. অন্তঃবিভাগ		
	খ. জরুরী বিভাগ		
	গ. বহিঃবিভাগ		
৯)	শয্যা ব্যবহারের হার (%)		
১০)	মোট গর্ভবতী পরিচর্যা		
	ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা)		
	খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা)		
	গ. মোট (সংখ্যা)		
১১)	মোট প্রসব সংখ্যা		
	ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব		
	খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব		
	গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব		

১২)	মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা		
১৩)	নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা		
১৪)	হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা		
১৫)	মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা		
১৬)	মেজর (বড়) অপারেশন		
	ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা)		
	খ. গাইনি/ অবস (সংখ্যা)		
	গ. অর্থোপেডিক (সংখ্যা)		
	ঘ. নাক- কান- গলা অপারেশন (সংখ্যা)		
	ঙ. চক্ষু অপারেশন (সংখ্যা)		
	চ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা)		
	ছ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা)		
১৭)	সার্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
১৮)	রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা (চালু কি না)		
	১. ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি	হ্যাঁ	না
	১. খ. এক্স- রে	হ্যাঁ	না
	১. গ. ই. সি. জি	হ্যাঁ	না
	২. ক. সি. বি. সি	হ্যাঁ	না
	২. খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি	হ্যাঁ	না
	২. খ. ১. লিপিড প্রোফাইল	হ্যাঁ	না
	২. খ. ২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট	হ্যাঁ	না
	২. খ. ৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন	হ্যাঁ	না
	২. খ. ৪. সেরাম ইউরিয়া	হ্যাঁ	না
	৩. ক. এইস. বি. এস. এ. জি	হ্যাঁ	না
	৩. খ. ব্লাড গ্লুকোজ	হ্যাঁ	না
	৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং	হ্যাঁ	না
১৯)	চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান		
	ক. তত্ত্বাধায়ক	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি	হ্যাঁ	না
	ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া	হ্যাঁ	না
	চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি	হ্যাঁ	না
	ছ. কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিকস	হ্যাঁ	না
	জ. কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি	হ্যাঁ	না
	ঝ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য	হ্যাঁ	না
	ঞ. কনসালটেন্ট, নাক, কান, গলা	হ্যাঁ	না
	ট. কনসালটেন্ট চক্ষু	হ্যাঁ	না

২০)	নার্স/ অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান		
	ক. নার্সিং সুপার	হ্যাঁ	না
	খ. ওটি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	গ. ইওসি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	ঙ. স্টোর ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	চ. প্রধান অফিস সহকারি	হ্যাঁ	না
২১)	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	হ্যাঁ	না
২২)	কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা		
	ক. জনবল সহায়তা		
	খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা		
	গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ		
২৩)	পরিবীক্ষণের জন্য মাসিক সভার সংখ্যা		
	ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি		
	খ. কমিউনিটি সহায়তা কমিটি		
	গ. সমন্বয় কমিটি		
	ঘ. কিউআইসি কমিটি		
	ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটি (প্রতি সপ্তাহে সভার সংখ্যা)		
২৪)	অভ্যর্থনা/ তথ্য কেন্দ্র	হ্যাঁ	না
২৫)	হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড	হ্যাঁ	না
২৬)	বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা		
	ক. এএনসি	হ্যাঁ	না
	খ. পিএনসি	হ্যাঁ	না
	গ. ভায়া	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইপিআই	হ্যাঁ	না
	ঙ. এনসিডি	হ্যাঁ	না
	চ. মাতৃদুগ্ধ পান	হ্যাঁ	না
	ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা	হ্যাঁ	না
২৭)	দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
২৮)	রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ		
	ক. তত্ত্বাবধায়ক নার্সিং	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. নার্সিং সুপার	হ্যাঁ	না
২৯)	কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন		
	ক. মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	খ. সার্জারি	হ্যাঁ	না
	গ. গাইনি	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইএনটি	হ্যাঁ	না

	ঙ. অর্থোপেডিকস	হ্যাঁ	না
	চ. চক্ষু	হ্যাঁ	না
	ছ. কার্ডিওলজি	হ্যাঁ	না
	জ. শিশু	হ্যাঁ	না
৩০)	রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা		
	ক. সাধারণ সার্জারি	হ্যাঁ	না
	খ. ইওসি	হ্যাঁ	না
	গ. অর্থোপেডিক	হ্যাঁ	না
	ঘ. চক্ষু	হ্যাঁ	না
	ঙ. নাক- কান- গলা	হ্যাঁ	না
৩১)	রোগীদের খাবার সামগ্রী	ক) প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কিনা?	
		খ)রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কিনা?	
৩২)			
৩৩)	বাৎসরিক মোট রাজস্ব আয়		
৩৪)	বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা		
৩৫)	মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা	হ্যাঁ	না

খ। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে

১)	উপজেলার নাম:		
২)	ক. ইউএইচএফপিও'র নাম:		
	খ. মোবাইল নং:		
	গ. ই- মেইল:		
৩)	হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা		
৪)	উপজেলার তথ্য		
	ক. উপজেলার মোট জনসংখ্যা		
	খ. মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা		
	গ. মোট ০-১ বছরের শিশু সংখ্যা		
	ঘ. মোট ০-৫ বছরের শিশু সংখ্যা		
৫)	মাসিক এইচএসএস নম্বরে অবস্থান		
	ক. সর্বনিম্ন:		
	খ. সর্বোচ্চ:		
৬)	বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ মাসওয়ারী (%)		
	ক. সর্বোচ্চ		
	খ. সর্বনিম্ন		
৭)	মানবসম্পদ	পদ সংখ্যা	শুন্যপদ
	১. ক. চিকিৎসকঃ		
	১. খ. মেডিকেল অফিসার		
	১. গ. কনসালটেন্ট		
	২. নার্সঃ		
	৩. পরিচ্ছন্ন কর্মী		
	৪. ওয়ার্ড বয়/ আয়াঃ		
৮)	মোট রোগীর সংখ্যা		
	ক. অন্তঃবিভাগ		
	খ. জরুরী বিভাগ		
	গ. বহিঃবিভাগ		
৯)	শয্যা ব্যবহারের হার (%)		
১০)	মোট গর্ভবতী পরিচর্যা		
	ক. ১ম ভিজিট (সংখ্যা)		
	খ. চতুর্থ ভিজিট (সংখ্যা)		
	গ. মোট (সংখ্যা)		
১১)	মোট প্রসব সংখ্যা		
	ক. মোট স্বাভাবিক প্রসব		
	খ. মোট সিজারিয়ান প্রসব		
	গ. রাতে সিজারিয়ান প্রসব		

১২)	মৃত জন্ম শিশুর সংখ্যা		
১৩)	নবজাতক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা		
১৪)	হাসপাতালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা		
১৫)	মোট প্রসবোত্তর পরিচর্যা		
১৬)	মেজর (বড়) অপারেশন		
	ক. জেনারেল সার্জারি (সংখ্যা)		
	খ. গাইনি/ অবস (সংখ্যা)		
	গ. ডেন্টাল অপারেশন (সংখ্যা)		
	ঘ. মোট মেজর অপারেশন (সংখ্যা)		
১৭)	ভায়া পরীক্ষার সংখ্যা (সর্বমোট)		
	ক. পজিটিভ (সংখ্যা)		
	খ. নেগেটিভ (সংখ্যা)		
১৮)	সর্বক্ষণিক রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
১৯)	রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা (চালু কি না)		
	১. ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি	হ্যাঁ	না
	১. খ. এক্স- রে	হ্যাঁ	না
	১. গ. ই. সি. জি	হ্যাঁ	না
	২. ক. সি. বি. সি	হ্যাঁ	না
	২. খ. বায়োকেমিস্ট্রি ও ইমিউনোলোজি	হ্যাঁ	না
	২. খ. ১. লিপিড প্রোফাইল	হ্যাঁ	না
	২. খ. ২. সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট	হ্যাঁ	না
	২. খ. ৩. সেরাম ক্রিয়েটিনিন	হ্যাঁ	না
	২. খ. ৪. সেরাম ইউরিয়া	হ্যাঁ	না
	৩. ক. এইস. বি. এস. এ. জি	হ্যাঁ	না
	৩. খ. ব্লাড গ্লুকোজ	হ্যাঁ	না
	৩. গ. রক্তগ্রুপ ও স্ক্রিনিং	হ্যাঁ	না
২০)	চিকিৎসকদের আবাসিক (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে) অবস্থান		
২১)	ক. ইউএইচএফপিও	হ্যাঁ	না
	খ. আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. কনসালটেন্ট, মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	ঘ. কনসালটেন্ট, সার্জারি	হ্যাঁ	না
	ঙ. কনসালটেন্ট, এনেসথেসিয়া	হ্যাঁ	না
	চ. কনসালটেন্ট, অবস গাইনি	হ্যাঁ	না
	ছ. কনসালটেন্ট, শিশু স্বাস্থ্য	হ্যাঁ	না
২২)	নার্স/ অন্যান্যদের আবাসিক অবস্থান		
	ক. নার্সিং সুপারভাইজার	হ্যাঁ	না
	খ. ওটি সিস্টার	হ্যাঁ	না

	গ. ইওসি সিস্টার	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইমার্জেন্সি ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	ঙ. স্টোর ইন চার্জ	হ্যাঁ	না
	চ. প্রধান অফিস সহকারি	হ্যাঁ	না
২৩)	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	হ্যাঁ	না
২৪)	কমিউনিটি হতে প্রাপ্ত সহযোগিতা		
	ক. জনবল সহায়তা		
	খ. চিকিৎসা সামগ্রী সহায়তা		
	গ. আর্থিক সহায়তার পরিমাণ		
২৫)	পরিবীক্ষণের জন্য মাসিক সভার সংখ্যা		
	ক. স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কমিটি		
	খ. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ		
	গ. সমন্বয় কমিটি		
	ঘ. কিউআইসি কমিটি		
	ঙ. ডাব্লুআইটি কমিটির সংখ্যা		
	চ. ডাব্লুআইটি কমিটির সভার সংখ্যা		
২৬)	অভ্যর্থনা/ তথ্য কেন্দ্র	হ্যাঁ	না
২৭)	হাসপাতালের প্রবেশ পথে সাইকেল স্ট্যান্ড	হ্যাঁ	না
২৮)	বহিঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা		
	ক. পুরুষ	হ্যাঁ	না
	খ. নারী	হ্যাঁ	না
	গ. শিশু	হ্যাঁ	না
	ঘ. প্রসূতি ও গাইনি	হ্যাঁ	না
২৯)	অন্তঃবিভাগে রোগী পৃথকীকরণের ব্যবস্থা		
	ক. পুরুষ	হ্যাঁ	না
	খ. নারী	হ্যাঁ	না
	গ. শিশু	হ্যাঁ	না
	ঘ. প্রসূতি ও গাইনি	হ্যাঁ	না
৩০)	বিষয়ভিত্তিক কর্নারের কার্যকারিতা		
	ক. এএনসি	হ্যাঁ	না
	খ. পিএনসি	হ্যাঁ	না
	গ. ভায়া	হ্যাঁ	না
	ঘ. ইপিআই	হ্যাঁ	না
	ঙ. এনসিডি	হ্যাঁ	না
	চ. মাতৃদুগ্ধ পান	হ্যাঁ	না
	ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা	হ্যাঁ	না
৩১)	দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	হ্যাঁ	না
৩২)	রাত্রীকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শনঃ		
	ক. ইউএইচএফপিও	হ্যাঁ	না

	খ. আবাসিক মেডিকেল অফিসার	হ্যাঁ	না
	গ. নার্সিং সুপারভাইজার	হ্যাঁ	না
৩৩)	কনসালটেন্টদের রাত্রিকালীন ওয়ার্ড পরিদর্শন		
	ক. মেডিসিন	হ্যাঁ	না
	খ. সার্জারি	হ্যাঁ	না
	গ. গাইনি	হ্যাঁ	না
	ঘ. শিশু	হ্যাঁ	না
৩৪)	রাত্রীকালীন জরুরী অপারেশন সুবিধা		
	ক. সাধারণ সার্জারি	হ্যাঁ	না
	খ. ইওসি	হ্যাঁ	না
৩৫)	রোগীদের খাবার সামগ্রী		
	ক. প্রতিদিন রোগীদের খাবার সামগ্রী কোনো কর্মকর্তা বুঝে নেন কি না?	হ্যাঁ	না
	খ. রান্না করা রোগীর খাদ্য কর্মকর্তা পরীক্ষা করেন কি না?	হ্যাঁ	না
৩৬)	এম্বুলেন্স সার্ভিস		
	ক. সচল কি না	হ্যাঁ	না
	খ. এম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে গত বছরের আয়		
৩৭)	বাৎসরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা		
৩৮)	মাসিক মৃত্যু পর্যালোচনা	হ্যাঁ	না

- সমাপ্ত-